melanome

Niveau : DES dermatologie
Genere le 14 April 2026

Base sur la litterature medicale indexee via DermatoRAG

melanome

Cours de niveau DES dermatologie — Généré par DermatoRAG

Épidémiologie et Introduction

Le mélanome est une tumeur agressive résultant de la transformation maligne des mélanocytes, cellules pigmentaires de la peau. Il représente une entité clinique et histopathologique hétérogène, caractérisée par une capacité de dissémination lymphatique et hématogène (Garbe et al., 2025). Bien qu'il puisse affecter une population plus jeune, avec un pic d'âge entre 20 et 45 ans, son incidence augmente avec l'âge (dermatology handbook compressed-compressed; Garbe et al., 2025). Le mélanome est également reconnu comme une tumeur immuno-sensible, ce qui influence sa présentation et sa réponse aux traitements, notamment chez les populations immunodéprimées (NCCN, 2026).

Les principaux facteurs pronostiques histologiques d'un mélanome primaire incluent l'épaisseur tumorale verticale (profondeur de Breslow), mesurée du sommet de la couche granuleuse de l'épiderme (ou de la base de l'ulcération si présente) jusqu'au point le plus profond d'invasion, ainsi que la présence d'une ulcération histologiquement définie (Garbe et al., 2025; dermatology handbook compressed-compressed). L'ulcération est caractérisée par un défaut épidermique sur toute l'épaisseur, l'absence de *stratum corneum* et de membrane basale, des signes de réponse de l'hôte (dépôt de fibrine, neutrophiles) et un amincissement ou une hyperplasie réactive de l'épiderme environnant (Garbe et al., 2025). Le taux mitotique tumoral (nombre de mitoses/mm²) était également un facteur pronostique indépendant dans plusieurs études de population, bien qu'il ne soit plus utilisé pour la sous-classification des mélanomes fins dans la 8ème révision du système de stadification de l'AJCC (Garbe et al., 2025; dermatology handbook compressed-compressed). D'autres facteurs de mauvais pronostic incluent l'âge avancé, le sexe masculin et la localisation de la tumeur sur le tronc ou la tête et le cou, par rapport aux membres (Garbe et al., 2025; dermatology handbook compressed-compressed). La stadification du mélanome est basée sur le système TNM de l'American Joint Committee on Cancer (AJCC), qui prend en compte l'étendue de la tumeur primaire, sa profondeur et la présence ou non d'ulcération, ainsi que l'atteinte ganglionnaire et les métastases à distance (Garbe et al., 2025; dermatology handbook compressed-compressed; NCCN, 2026). Les mélanomes peuvent métastaser par voie lymphatique ou hématogène, avec environ deux tiers des métastases initialement confinées aux aires ganglionnaires régionales (Garbe et al., 2025). Le taux de survie à 10 ans pour certains mélanomes est de 85 à 95 % (Garbe et al., 2025).

Il existe quatre types cliniques principaux de mélanome cutané: le mélanome à extension superficielle (MES), le plus fréquent (70 % dans la population blanche), se présentant comme une macule ou une fine plaque pigmentée avec une croissance horizontale; le mélanome nodulaire (MN), deuxième type le plus courant chez les patients à peau claire, caractérisé par une papule ou un nodule rapidement évolutif avec une croissance verticale; le mélanome de Dubreuilh (LMM), moins fréquent, évoluant à partir d'un *lentigo maligna*

sur des zones exposées au soleil chez les personnes âgées; et le mélanome acrolentigineux (MAL), le plus courant chez les patients à peau foncée, souvent localisé sur les extrémités (dermatology handbook compressed-compressed). Il est important de noter que le mélanome uvéal et les mélanomes des muqueuses sont des entités distinctes, dont la prise en charge est décrite dans des guides spécifiques (Amaral et al., 2025).

Épidémiologie

Incidence et Mortalité

L'incidence du mélanome est en augmentation constante à l'échelle mondiale, particulièrement au sein des populations caucasiennes exposées de manière excessive au soleil (Garbe et al., 2025). L'Agence Internationale de Recherche sur le Cancer (IARC) a estimé à 325 000 le nombre de nouveaux cas de mélanome dans le monde en 2020, avec une légère prédominance masculine (174 000 hommes contre 151 000 femmes). Le nombre de décès attribués au mélanome s'élevait à 57 000 la même année (32 000 hommes contre 25 000 femmes) (Garbe et al., 2025).

Des variations géographiques significatives sont observées dans les taux d'incidence standardisés selon l'âge. L'Australie et la Nouvelle-Zélande affichent les taux les plus élevés, avec 42 cas pour 100 000 personnes/an chez les hommes et 31 cas pour 100 000 personnes/an chez les femmes. En Europe de l'Ouest, l'incidence est d'environ 19 cas pour 100 000 personnes/an pour les deux sexes, tandis qu'en Amérique du Nord, elle est de 18 cas pour 100 000 personnes/an chez les hommes et 14 cas pour 100 000 personnes/an chez les femmes (Garbe et al., 2025). Le mélanome est rare dans les populations de couleur, notamment en Afrique et en Asie, où les taux d'incidence sont généralement inférieurs à 1 cas pour 100 000 personnes/an (Garbe et al., 2025).

L'

Présentation Clinique

Présentation Clinique du Mélanome Cutané

La présentation clinique du mélanome cutané est polymorphe, rendant son diagnostic un défi pour le clinicien. Une approche systématique combinant l'examen clinique visuel et la dermatoscopie est essentielle pour optimiser la détection précoce de cette tumeur agressive.

1. Diagnostic Clinique Macroscopique

Le diagnostic clinique du mélanome repose sur une évaluation minutieuse des lésions pigmentées et non pigmentées, en tenant compte de leurs caractéristiques morphologiques et de leur évolution. La sensibilité du diagnostic clinique par des dermatologues expérimentés est estimée à environ 70 % (Garbe et al., 2025).

1.1. Critères Diagnostiques Fondamentaux

Les caractéristiques macroscopiques typiques du mélanome sont synthétisées par la règle mnémotechnique **ABCD** (Garbe et al., 2025) :

- **A**symétrie de la lésion.
- **B**ords irréguliers.
- **C**ouleurs variables (polychromie).
- **D**iamètre supérieur à 5 mm.

L'évolution de la lésion est un critère majeur, le mélanome étant presque toujours caractérisé par une croissance et/ou un changement de forme et/ou de couleur (Garbe et al., 2025). Des signes d'évolution tumorale, tels que l'ulcération et le développement d'une composante nodulaire, peuvent apparaître au cours de la progression de la maladie (Garbe et al., 2025).

Pour les mélanomes nodulaires (MN), qui peuvent manquer des caractéristiques pigmentaires et d'asymétrie de la règle ABCD, la règle **EFG** est particulièrement pertinente (Garbe et al., 2025) :

- **E**levated (surélevé).
- **F**irm (ferme à la palpation).
- **G**rowing (en croissance rapide).

Ces critères doivent inciter à l'excision rapide d'un mélanome potentiellement agressif (Garbe et al., 2025).

1.2. Approche de l'Examen Clinique

L'approche diagnostique clinique du mélanome comprend plusieurs étapes clés (Garbe et al., 2025) :

• **Examen visuel corporel total** : Recherche de lésions présentant un ou plusieurs des critères ABCDE susmentionnés. Cet examen inclut impérativement les zones moins exposées comme les organes génitaux, la muqueuse buccale et le cuir chevelu (Garbe et al., 2025).

• **Analyse comparative intra-individuelle (signe du vilain petit canard)** : Identification d'une lésion qui diffère des autres chez le même patient (Garbe et al., 2025).

• **Évaluation de l'évolution des lésions** : Si une documentation antérieure (photographies cliniques) est disponible, elle permet d'apprécier les changements morphologiques au fil du temps (Garbe et al., 2025).

1.3. Types Cliniques Spécifiques de Mélanome

La présentation clinique varie considérablement en fonction du sous-type histologique du mélanome (Garbe et al., 2025).

1.3.1. Mélanome à Extension Superficielle (MES)

Le MES est le type le plus fréquent, représentant environ 70 % des mélanomes dans la population caucasienne (Dermatology handbook compressed-compressed). Il se présente généralement comme une macule ou une fine plaque de couleur foncée, avec des bords parfois crénelés et des nuances variées de brun. Des zones de régression peuvent être observées. Les localisations les plus courantes sont le dos chez l'homme et les membres inférieurs chez la femme. Sa croissance est initialement horizontale (Dermatology handbook compressed-compressed). Cliniquement, il peut apparaître comme une lésion de 5 mm de diamètre avec une asymétrie de couleurs (brun et rose) (Garbe et al., 2025, Fig. 2B).

1.3.2. Mélanome Nodulaire (MN)

Le MN est le deuxième type le plus courant chez les patients à peau claire (Dermatology handbook compressed-compressed). Il se caractérise par une papule ou un nodule fortement pigmenté, d'apparition rapide. Sa croissance est principalement verticale, ce qui en fait un sous-type potentiellement plus agressif. Il peut présenter des colorations bleuâtres et rosées (Garbe et al., 2025, Fig. 2C).

1.3.3. Lentigo Maligna Mélanome (LMM)

Le LMM est le type le moins fréquent et se développe à partir d'un lentigo malin préexistant (Dermatology handbook compressed-compressed). Il survient typiquement sur les zones chroniquement exposées au soleil chez les sujets âgés, notamment le visage (Dermatology handbook compressed-compressed). Il se manifeste comme une plaque hyperpigmentée avec des nuances de brun variées et des bords irréguliers (Dermatology

handbook compressed-compressed). Cliniquement, il apparaît comme une lésion plate, pigmentée, de couleur brune sur le visage (Garbe et al., 2025, Fig. 2A).

1.3.4. Mélanome Acrolentigineux (MAL)

Le MAL est le type le plus fréquent chez les patients à peau foncée (Dermatology handbook compressed-compressed). Il se présente comme une plaque hyperpigmentée avec des nuances de brun ou de noir et des bords irréguliers, localisée sur les extrémités (paumes, plantes, régions sous-unguéales) (Dermatology handbook compressed-compressed). Une lésion précoce sur la plante du pied peut montrer une pigmentation asymétrique, noire, grise et brune (Garbe et al., 2025, Fig. 3A).

1.3.5. Mélanome Sous-Unguéal

Le mélanome sous-unguéal se manifeste cliniquement comme une bande pigmentée de l'ongle (mélanonychie) (Garbe et al., 2025). Une présentation typique est une mélanonychie brun foncé de forme triangulaire (Garbe et al., 2025, Fig. 3B). Le signe de Hutchinson, caractérisé par l'extension de la pigmentation à la peau péri-unguéale, est un signe clinique important (Garbe et al., 2025 ; Dermatology handbook compressed-compressed, Fig 5.12C).

1.3.6. Mélanome Muqueux

Le mélanome muqueux peut se présenter sous diverses formes, y compris comme un nodule amélanotique (Garbe et al., 2025, Fig. 3C). Il peut affecter les muqueuses de la tête et du cou, les régions génito-urinaires et anorectales (Ortiz, 2024).

1.3.7. Mélanome Hypo- ou Amélanotique

Moins fréquemment, le mélanome peut être hypo- ou amélanotique, ce qui rend sa reconnaissance particulièrement difficile en l'absence de pigmentation (Garbe et al., 2025). Dans ces cas, les critères de la règle ABCD sont absents ou peu évocateurs, et l'attention doit être portée sur les caractéristiques morphologiques et vasculaires (cf. section 2.3.2) (Garbe et al., 2025).

1.4. Diagnostic Différentiel Clinique

Le diagnostic différentiel clinique du mélanome est vaste et inclut (Garbe et al., 2025) :

- **Lésions mélanocytaires pigmentées** : Naevi mélanocytaires communs, congénitaux ou atypiques.
- **Lésions non mélanocytaires pigmentées** : Kératoses séborrhéiques, lentigos actiniques, hémangiomes, dermatofibromes, carcinomes basocellulaires pigmentés.
- **T

Diagnostic

Diagnostic du Mélanome Cutané

Le diagnostic du mélanome cutané repose sur une approche méthodique et multidisciplinaire, combinant l'examen clinique, la dermatoscopie, l'histopathologie et, si nécessaire, des investigations complémentaires pour le bilan d'extension et la caractérisation moléculaire. L'objectif est d'affirmer la nature mélanocytaire et maligne de la lésion, de déterminer son sous-type anatomoclinique, d'évaluer les facteurs pronostiques et de stadifier la maladie afin d'orienter la prise en charge thérapeutique.

1. Approche Clinique et Dermatoscopique

Le diagnostic initial du mélanome est clinique et doit toujours être confirmé par la dermatoscopie (Garbe et al., 2025). La sensibilité du diagnostic clinique par des dermatologues expérimentés est estimée à environ 70 % (Garbe et al., 2025).

1.1. Examen Clinique

L'examen clinique repose sur une inspection visuelle complète de la peau à la recherche de lésions suspectes. Plusieurs règles mnémotechniques guident cette évaluation :

- **Règle ABCD(E)** : Cette règle résume les caractéristiques macroscopiques typiques du mélanome (Garbe et al., 2025) :

* **A**symétrie de la lésion.

* **B**ords irréguliers.

* **C**ouleur variable (multiples couleurs).

* **D**iamètre supérieur à 5 mm.

* **É**volution : changement de forme et/ou de couleur de la lésion au fil du temps (Garbe et al., 2025). L'ulcération et une composante nodulaire peuvent apparaître avec l'évolution de la tumeur (Garbe et al., 2025).

- **Règle EFG** : Particulièrement pertinente pour le mélanome nodulaire (MN) qui peut manquer des caractéristiques ABCD(E) (Garbe et al., 2025). Elle signifie :

* **É**levé (Elevated).

* **F**erme (Firm).

* **G**rossissant (Growing).

Cette règle doit inciter à l'excision rapide d'un mélanome potentiellement agressif (Garbe et al., 2025).

- **Signe du vilain petit canard (Ugly Duckling Sign)** : Il s'agit de la recherche de la lésion qui ne ressemble pas aux autres chez le même patient (Garbe et al., 2025).
- **Analyse comparative intra-individuelle** : L'évaluation de l'évolution des lésions est cruciale, surtout si une documentation antérieure est disponible (Garbe et al., 2025).

Le diagnostic différentiel clinique du mélanome inclut d'autres lésions mélanocytaires pigmentées (naevi congénitaux, atypiques et communs), des lésions pigmentées non mélanocytaires (kératose séborrhéique, lentigo actinique, hémangiome, dermatofibrome, carcinome basocellulaire pigmenté) et d'autres tumeurs non pigmentées (hémangiome, carcinome basocellulaire, carcinome épidermoïde) (Garbe et al., 2025). Il est important de noter que le mélanome peut être hypo- ou amélanotique, rendant sa reconnaissance particulièrement difficile (Garbe et al., 2025).

1.2. Dermatoscopie

La dermatoscopie est un outil indispensable dans l'évaluation clinique des tumeurs cutanées et doit toujours être utilisée (Garbe et al., 2025). Une formation en dermatoscopie est obligatoire, car la technique devient plus bénéfique avec l'expérience croissante (Garbe et al., 2025). Une méta-analyse a montré que les experts utilisant la dermatoscopie augmentent la précision diagnostique par rapport au diagnostic clinique seul, atteignant une sensibilité de 89 % et une spécificité de 79 % pour les lésions douteuses (Garbe et al., 2025).

Les caractéristiques dermatoscopiques du mélanome incluent une asymétrie des structures et des couleurs multiples (Garbe et al., 2025). Les signes spécifiques comprennent un réseau pigmentaire atypique, des points/globules/amas brun-noir irréguliers, des stries irrégulières, des taches/zones hyperpigmentées irrégulières, des stries/lignes blanches brillantes et des structures de régression (Garbe et al., 2025). Des critères additionnels comme le voile bleu-blanc et les vaisseaux polymorphes sont fréquents dans le mélanome invasif (Garbe et al., 2025).

Des caractéristiques dermatoscopiques spécifiques sont observées selon les sous-types :

- **Mélanome amélanotique** : Manque la plupart des critères pigmentaires et est caractérisé par un motif vasculaire polymorphe et des stries/lignes blanches brillantes (Garbe et al., 2025).
- **Mélanome acral lentigineux (MAL)** : Présente typiquement un motif en crêtes parallèles et une pigmentation diffuse irrégulière, bien que d'autres critères de mélanome puissent être présents (Garbe et al., 2025). Le MAL in situ de la plante du pied, par exemple, peut montrer une pigmentation asymétrique noire, grise et brune, avec un motif en crêtes parallèles caractéristique à la dermatoscopie (Garbe et al., 2025). Le MAL sous-unguéal se manifeste comme une bande unguéale pigmentée, caractérisée par des lignes irrégulières en épaisseur et en couleur, et une extension de la pigmentation à la peau péri-unguéale (signe de Hutchinson et micro-Hutchinson) (Garbe et al., 2025).

• **Mélanome de Dubreuilh (Lentigo Maligna Melanoma - LMM)** : Le modèle de progression dermatoscopique prototypique pour le LMM sur le visage inclut quatre motifs séquentiels : motif annulaire-granulaire, ouvertures folliculaires pigmentées asymétriquement, structures rhomboïdales (Garbe et al., 2025). L'importance de caractéristiques additionnelles telles qu'un réseau vasculaire augmenté et des structures rhomboïdales rouges a été liée au développement d'une néovascularisation induite par la tumeur (Garbe et al., 2025).
• **Mélanome muqueux** : Caractérisé par des couleurs multiples, incluant diverses combinaisons de brun, noir, bleu, rouge, blanc et gris (Garbe et al., 2025).

La dermatoscopie doit être appliquée à toutes les lésions, et pas seulement aux lésions cliniquement suspectes, car elle peut révéler une asymétrie morphologique avant qu'elle ne soit cliniquement reconnaissable (Garbe et al., 2025). Une documentation photographique clinique et dermatoscopique de la tumeur primaire avant l'excision est recommandée (Garbe et al., 2025). En cas de forte suspicion clinique et d'indisponibilité de la dermatoscopie, l'excision ne doit pas être retardée (Garbe et al., 2025).

1.3. Outils Complémentaires au Diagnostic Clinique

• **Photographie corporelle totale (Total Body Photography - TBP) et dermatoscopie digitale séquentielle** : Ces techniques contribuent significativement à la détection précoce du mélanome, en particulier chez les individus à haut risque (prédisposition génétique, antécédents personnels de mélanome, nombre élevé de naevi, etc.) (Garbe et al., 2025). La documentation dermatoscopique séquentielle est particulièrement utile chez les patients à haut risque avec de multiples naevi atypiques, facilitant la détection du mélanome et la réduction des excisions inutiles (Garbe et al., 2025).
• **Microscopie confocale à réflectance (MCR)** : Si disponible, la MCR peut améliorer le diagnostic clinique dans des cas particuliers (Garbe et al., 2025).
• **Intelligence Artificielle (IA)** : L'IA peut aider à la détection de nouvelles lésions, à l'identification des changements et à la fourniture de scores de risque pour les lésions mélanocytaires (Garbe et al., 2025). Des algorithmes basés sur l'IA ont montré une augmentation de la précision du diagnostic du mélanome pour les dermatologues et ont été certifiés comme dispositifs médicaux en Europe (Garbe et al., 2025). Cependant, la prudence est de mise lors de l'extrapolation des résultats d'études expérimentales à la pratique clinique réelle (Garbe et al., 2025).

2. Diagnostic Histopathologique

L'examen histopathologique est obligatoire pour toute lésion cutanée suspecte excisée chirurgicalement (Garbe et al., 2025). Pour une évaluation optimale de l'architecture de la lésion mélanocytaire, le mélanome doit toujours être complètement excisé si possible (Garbe et al., 2025). L'exérèse-biopsie avec une marge clinique minimale (1-3 mm) est préférée pour fournir un spécimen optimal au dermatopathologiste et permettre l'évaluation des marges d'excision pour une tumeur résiduelle (Garbe et al., 2025). Les biopsies

incisionnelles ne devraient pas être réalisées lorsque l'exérèse-biopsie est techniquement possible, car elles peuvent entraîner des erreurs de diagnostic dues à un échantillonnage incomplet et compromettre l'analyse des caractéristiques architecturales ou l'estimation de l'épaisseur de Breslow (Garbe et al., 2025). Cependant, une biopsie incisionnelle peut être nécessaire pour confirmer le diagnostic dans des situations spécifiques, telles qu'un lentigo maligna étendu de la tête et du cou, ou un mélanome acral ou muqueux (Garbe et al., 2025).

2.1. Rôle de l'Histopathologie

L'examen histologique permet de (Dermatologie, 2022) :

- **Affirmer la nature mélanocytaire** : L'intérêt des marquages immunohistochimiques est primordial à cet égard.
- **Affirmer la malignité et déterminer le sous-type anatomoclinique**.
- **Recueillir les paramètres histopronostiques fondamentaux** : indice de Breslow, ulcération, index mitotique.
- **Préciser le caractère complet ou non de l'exérèse** : Une reprise chirurgicale est de toute façon effectuée si les marges sont positives.
- **Rechercher d'emblée la présence d'une mutation de BRAF** sur la pièce, selon l'avis de la Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP), notamment pour les tumeurs épaisses de mauvais pronostic.

2.2. Marquages Immunohistochimiques

L'immunohistochimie est de plus en plus utilisée, surtout lorsque le diagnostic n'est pas clair (Garbe et al., 2025). Bien qu'il n'existe pas de marqueur certain de malignité, la nature mélanocytaire et l'architecture de la lésion peuvent être mieux évaluées (Garbe et al., 2025). Les marqueurs préférés dans le diagnostic du mélanome sont (Garbe et al., 2025) :

- **Protéine S100** : Protéine liant le calcium, souvent fortement positive dans les cellules de mélanome (Dermatologie, 2022 ; Garbe et al., 2025).
- **Melan-A (MART-1)** : Marqueur spécifique des mélanocytes, généralement fortement positif dans les cellules de mélanome (Dermatologie, 2022 ; Garbe et al., 2025).
- **HMB-45** : Autre marqueur spécifique des mélanocytes, souvent positif dans les cellules de mélanome, il colore le cytoplasme des mélanocytes et des cellules de mélanome (Dermatologie, 2022 ; Garbe et al., 2025).
- **Tyrosinase** : Enzyme impliquée dans la synthèse de la mélanine, exprimée dans les mélanocytes et les cellules de mélanome, utile pour le diagnostic (Garbe et al., 2025).
- **SOX10** : Facteur de transcription impliqué dans le développement des mélanocytes, exprimé dans les cellules de mélanome (Garbe et al., 2025).
- **MITF (Microphthalmia-associated transcription factor)** : Facteur de transcription impliqué dans la différenciation des mélanocytes, souvent exprimé dans les cellules de mélanome (Garbe et al., 2025).

• **Ki-67** : Marqueur de la prolifération cellulaire, utilisé pour évaluer l'activité proliférative des cellules de mélanome (Garbe et al., 2025).

2.3. Contenu du Compte-rendu Histopathologique Synoptique

Le compte-rendu histopathologique synoptique doit inclure les informations suivantes (Garbe et al., 2025) :

• **Diagnostic et sous-type clinicopathologique** (SSM, MN, LMM, MAL, mélanome desmoplastique). En cas d'incertitude sur la malignité, cela doit être clairement indiqué dans la conclusion du rapport.
• **Épaisseur tumorale en mm (indice de Breslow)**.
• **Niveau de Clark (anatomique) I-V**.
• **Présence ou absence d'ulcération**.
• **Présence ou absence de régression établie**.
• **Microsatellites** (si présents), définis comme tout nid discontinu de cellules métastatiques intralymphatiques de > 0,05 mm de diamètre, clairement séparé par du derme normal ou du tissu adipeux sous-cutané de la composante invasive de la tumeur par une distance d'au moins 0,3 mm.
• **Marges d'excision latérales et profondes**.
• **Mitoses par mm²** (dans les zones les plus actives), si disponibles.

2.4. Classification Anatomoclinique et Caractéristiques Histologiques des Sous-types

La classification anatomoclinique résume les différents profils de mélanome en cinq grandes catégories (Dermatologie, 2022) :

• **Mélanomes avec phase d'extension horizontale initiale** :

* **Mélanome superficiel extensif (MSE ou SSM)** : Le plus fréquent (60 à 70 % des cas), avec une croissance intra-épidermique horizontale, puis verticale dermique (Dermatologie, 2022). Histologiquement, il déb

Traitement

Le traitement du mélanome cutané, une pathologie oncologique complexe, requiert une approche multidisciplinaire et individualisée, s'inscrivant dans une stratégie thérapeutique au long cours. Les décisions sont idéalement prises au sein d'une équipe d'oncologie interdisciplinaire, communément appelée "Tumor Board" (Garbe et al., 2025). Une information complète du patient sur sa maladie et les options thérapeutiques est essentielle pour favoriser son adhésion et sa participation active aux choix de prise en charge (Dermatologie, 2022).

1. Principes Généraux du Traitement

La prise en charge du mélanome a connu des avancées majeures, notamment avec l'avènement des immunothérapies et des thé

Surveillance et Suivi

Surveillance et Suivi du Mélanome Cutané

1. Introduction et Objectifs de la Surveillance

La surveillance et le suivi des patients atteints de mélanome cutané constituent une composante essentielle de la prise en charge post-thérapeutique, visant à optimiser les résultats cliniques et à améliorer la qualité de vie des patients. Bien que l'impact précis d'une surveillance intensive sur le pronostic des patients atteints de mélanome soit difficile à documenter, l'hypothèse sous-jacente est qu'un programme de suivi structuré permettrait une détection plus précoce des récidives, à un stade où elles seraient plus accessibles à des traitements potentiellement curatifs (NCCN, 2026). Cette rationalité est

Bibliographie

• cutaneous_melanoma

• Garbe et al. - 2025 - European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 1 Diagnostics - Update 2024

• dermatology handbook compressed-compressed

• Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed

• Amaral et al. - 2025 - Cutaneous melanoma ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up

• Ortiz-Urda et al. - 2024 - Melanoma From Diagnosis to Therapy

• margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practical

• Dummer et al. - 2016 - The 12-month analysis from Basal Cell Carcinoma Outcomes with LDE225 Treatment (BOLT) A phase II, r

• Alikhan-and-Hocker-Review-of-Dermatology-2nd-edition compressed

• Garbe et al. - 2025 - European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 2 Treatment – Update 2024

• nmsc

• Robert et al. - 2015 - Pembrolizumab versus Ipilimumab in Advanced Melanoma

• Seth et al. - 2023 - Systemic Therapy for Melanoma ASCO Guideline Update

• Long et al. - 2017 - Adjuvant Dabrafenib plus Trametinib in Stage III BRAF -Mutated Melanoma